

ALTERACIONES CORNEALES

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García

INTRODUCCIÓN

Alteración corneal engloba una amplísima variedad de patologías. Es un motivo frecuente de consulta tanto por su elevada incidencia como por sus molestos síntomas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Síndrome de ojo seco

La función o el volumen lagrimal son inadecuados y generan una película lagrimal inestable, inflamación y daño de la superficie ocular. Es más frecuente en ancianos, mujeres postmenopáusicas y tras cirugía ocular.

El paciente refiere sensación de cuerpo extraño, sequedad, quemazón y visión borrosa transitoria, que empeoran a lo largo del día y mejoran con el parpadeo. La evaporación lagrimal favorecida por la calefacción, el aire acondicionado, o la reducción de la frecuencia de parpadeo (como ocurre al leer), empeora los síntomas.

La conjuntiva se muestra hiperémica y con tinción puntiforme por fluoresceína. La córnea presenta pequeñas erosiones epiteliales fluo +, pudiendo asociar pequeños filamentos por acúmulo de moco y células descamadas (queratitis filamentosa). En casos severos aparecen úlceras con riesgo de sobreinfección bacteriana e incluso de perforación corneal.

La base del tratamiento son las lágrimas artificiales (preferiblemente sin conservantes) al menos 3-4 veces al día. Los corticoides tópicos de baja intensidad se utilizan en el cuadro agudo (colirio de fluorometolona al 0.1% cada 8 horas durante 4 – 7 días). Optimización de la humedad ambiental (reducción de la temperatura ambiente y uso de humidificadores).

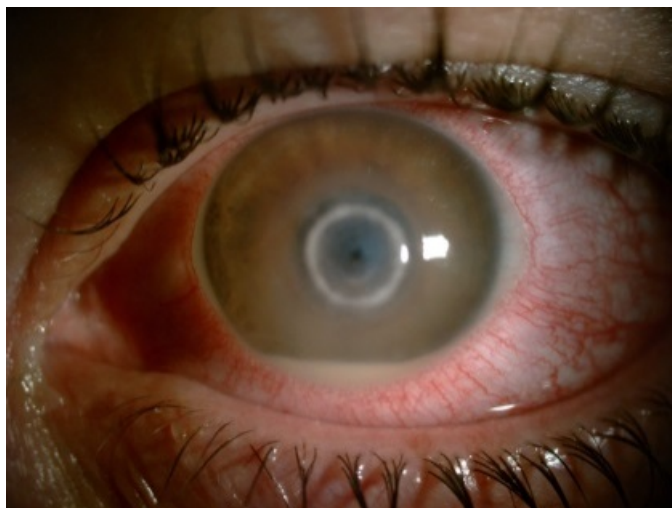
Erosión corneal y erosión corneal recurrente.

Pequeños traumatismos lesionan la córnea produciendo desepitelización (fluor +) muy dolorosa que debe ser tratada con lubricación ocular y antibiótico tópico (p. ej. colirio de ofloxacino 3mg/ml cada 6 horas durante 7 días). Algunas abrasiones corneales traumáticas (roce de una uña o un papel) recidivan generando episodios recurrentes de dolor y fotofobia (se producen al despertar el paciente por falta de adherencia del epitelio corneal a la capa subyacente). Al tratamiento previo debe añadirse un gel de lubricación nocturna.

Queratitis bacteriana

Es el tipo más común de queratitis infecciosa. Los gérmenes más frecuentes son *Staphylococcus**, *Pseudomonas**, *Streptococcus**, *Moraxella* y *Serratia**. Los factores de riesgo son el uso de lentes de contacto, la alteración corneal traumática (incluyendo cirugías), la enfermedad de superficie ocular (queratitis herpética, ojo seco) y factores de inmunosupresión local o sistémica, como la diabetes.

El paciente presenta dolor, fotofobia, visión borrosa y aumento de secreción monocular. A la exploración aparece un defecto epitelial sobre un área de infiltración, con hiperemia y quemosis conjuntival. En casos graves ocasiona uveítis anterior, hipopion, epiescleritis, escleritis, endoftalmitis y perforación corneal.



Queratitis por *Pseudomonas**, infiltrado estromal e hipopion.

- Una úlcera infiltrada siempre debe tratarse como bacteriana inicialmente.

Tratamiento

- Infiltrado periférico pequeño con poca reacción en cámara anterior en no usuarios de lentes de contacto: fluoroquinolona tópica (colirio de ofloxacino cada 1–2 horas).
- Usuario de lentes de contacto: añadir pomada de tobramicina cada 8–12 horas.
- Lesión central, grande, o con importante reacción en cámara anterior: colirios reforzados (colirio de tobramicina o gentamicina reforzada [15mg/ml] cada hora, alternando con colirio de cefazolina reforzada [50mg/ml] o colirio de vancomicina reforzada [25mg/ml] en pauta horaria).
- Ciclopléjico (p.ej. colirio de ciclopentolato 1% cada 8-12 horas).
- Antibiótico sistémico si se sospecha infección por *Neisseria meningitidis**, *Haemophilus influenzae* o *Neisseria gonorrhoeae**.
- Enfermedad muy agresiva o duda sobre el cumplimiento terapéutico: plantear ingreso hospitalario.
- Evitar el uso de lentes de contacto.
- **Nunca ocluir ante sospecha de etiología infecciosa.**

Queratitis herpética

Es una importante causa de ceguera en países desarrollados. Los principales agentes etiológicos son el virus herpes simple (VHS, serotipos 1 y 2) y el virus varicela zóster (VVZ).

Queratitis por herpes simple (VHS)

Es una enfermedad ocular recurrente (10%–50% a los 10 años). Se caracteriza por la ulceración corneal dendrítica o geográfica. El paciente refiere malestar ocular, enrojecimiento, fotofobia y visión borrosa. Suele comenzar con una epitelitis punteada, que evoluciona a úlcera lineal con ramificaciones (úlceras dendríticas) tras la descamación del epitelio. Es característica la hipoestesia corneal. En ocasiones hay inflamación en cámara anterior, puede aumentar la presión intraocular (PIO) o pueden aparecer vesículas herpéticas palpebrales. Al cicatrizar la lesión deja un leucoma estromal residual que aumenta en cada recurrencia.



Queratitis por VHS, Úlcera dendrítica fluo – positiva.

Tratamiento: pomada oftálmica de aciclovir 3%, 5 veces al día. En niños, pacientes inmunodeprimidos, casos graves o recurrencia frecuente: aciclovir oral 200-400mg 5 tomas al día. Puede añadirse un antibiótico profiláctico (p. ej. colirio de ofloxacino 3mg/ml cada 6 horas).

Infección por herpes zoster (VVZ) oftálmico

Se trata de la afectación por VVZ de la primera rama (oftálmica) del nervio trigémino (V par craneal), con erupción cutánea sobre este dermatoma. La afectación ocular es frecuente y diversa, provoca conjuntivitis, queratitis, epiescleritis, escleritis, uveítis (anterior, con o sin elevación de la PIO, y posterior), neuritis óptica y parálisis de otros nervios.

El signo ocular más frecuente es la queratitis epitelial en forma de pequeña úlcera dendrítica, aparece en los primeros días de erupción cutánea y se resuelve espontáneamente en la siguiente semana. Otros hallazgos son queratitis numular (depósitos subepiteliales y leucoma estromal circundante, responde bien a corticoide tópico), queratitis estromal (leucoma denso, no responde a corticoide) o queratitis disciforme (endotelitis inmunomediada).

Tratamiento: aciclovir oral 800mg 5 veces diarias durante 7–10 días, famciclovir 250–500mg 3 veces al día, valaciclovir 1g 3 veces al día o brivudina 125mg cada 24 horas. En casos graves aciclovir intravenoso 5–10 mg/kg 3 veces diarias. Puede añadirse tratamiento antibiótico y antiviral tópico. Las lesiones cutáneas se curarán con antisepsia y secado.

Pinguécula y pterigium

La pinguécula es una lesión conjuntival blanquecina, poco elevada, adyacente al limbo en el espacio interpalpebral. El pterigium es un pliegue fibrovascular conjuntival que invade la córnea en zona interpalpebral. Ambas aparecen por degeneración elastótica de capas conjuntivales profundas secundaria a irritación y exposición solar crónica.

La clínica consiste en irritación, enrojecimiento y sensación de cuerpo extraño. En la exploración podemos encontrar epiteliopatía punteada circundante, e incluso adelgazamiento corneal (Ver **Adelgazamiento / ulceración corneal periférica - Dellen**).

Tratamiento: lubricantes oculares, corticoide tópico en lesiones inflamadas (colirio de fluorometolona 0.1%, cada 6 horas durante 5–7 días). Debe hacerse hincapié en el uso de protección solar y evitar ambientes y agentes irritantes (polvo, viento).

Adelgazamiento / ulceración corneal periférica

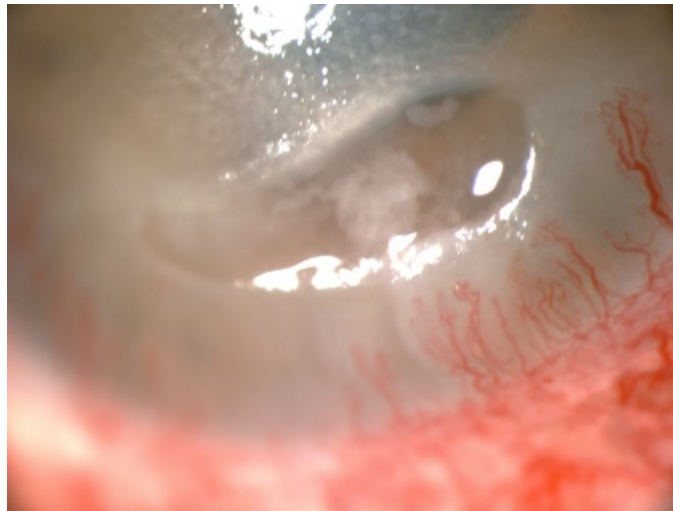
Aparece en periferia corneal y se extiende dibujando la silueta del limbo, circunferencialmente. Se describen a continuación los principales tipos.

Dellen

La alteración corneal es adyacente a una lesión sobreelevada de la conjuntiva, como una pinguécula o un hiposfagma, lo que conlleva una mala lubricación de la zona ulcerada. El tratamiento consiste en aplicar lágrimas artificiales. Puede añadirse un colirio antibiótico.

Queratitis ulcerativa periférica (peripheral ulcerative keratitis, PUK)

Se trata de una úlcera periférica, con infiltración estromal en la zona limbar. Puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica subyacente como artritis reumatoide o granulomatosis de Wegener. El tratamiento es el de la enfermedad de base.



Queratitis ulcerativa periférica.

A nivel ocular debe aplicarse antibiótico tópico (p. ej. colirio de ofloxacino 3 mg/ml cada 6 horas durante 7 días) y lubricantes oculares muy frecuentemente. Los colirios de corticoide pueden empeorar el adelgazamiento corneal y deben usarse con precaución. En algunos casos es necesario añadir corticoides o tetraciclinas por vía oral.

Queratopatía por exposición

Cuadro similar al ojo seco que ocurre como consecuencia del cierre incompleto de los párpados (lagofthalmos). Las lesiones aparecen en la zona expuesta al intentar el cierre palpebral.

Tratamiento: lubricantes de superficie ocular, antibiótico tópico ante úlceras con riesgo de sobreinfección (p. ej. colirio de ofloxacino 3 mg/ml, una gota cada 6 horas durante 7 días) y oclusión mecánica nocturna.

Queratopatía térmica / por radiación ultravioleta

Ocurre tras el uso de un arco de soldadura sin protección ocular. Produce dolor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia que comienzan 6–12 horas tras la exposición. En la exploración aparecen epiteliopatía punteada interpalpebral e hiperemia.

Tratamiento: ciclopléjico (colirio de ciclopentolato 1%, 1 o 2 veces al día durante 2, 3 días) y antibiótico (eritromicina pomada oftálmica cada 8 horas durante 5 días). Analgesia oral.

Problemas relacionados con lentes de contacto

La queratitis mecánica y la queratitis hipóxica ocurren por la baja transmisión de oxígeno a través de la lente y por la mala circulación de lágrima bajo la misma produciendo epitelopatía punteada, quistes epiteliales periféricos y ampollas endoteliales. Su tratamiento pasa por el ajuste adecuado de la lente de contacto y por la disminución del tiempo de uso.

La queratitis por hipersensibilidad ocurre por la respuesta inmune a algún agente bacteriano o a los productos que se usan en la higiene de la lente. Aparecen infiltrados corneales periféricos estériles. El tratamiento consiste en antibiótico y corticoide tópico.

La queratitis tóxica ocurre por el efecto nocivo de los agentes utilizados para la limpieza de la lente, como el tiomersal o el cloruro de benzalconio. Aparece dolor agudo, enrojecimiento y quemosis, que remiten en 24–48 horas. Tratamiento: sustituir las lentes habituales por lentes diarias desechables y utilizar desinfectantes sin conservantes.

En cuanto a la queratitis supurativa o bacteriana, el uso de lentes de contacto es el principal factor de riesgo para su aparición. (Ver: **Queratitis bacterianas**).

Puede desarrollarse también conjuntivitis papilar gigante (Ver tema: **Conjuntivitis**).

BIBLIOGRAFÍA

- Kanski JJ, Bowling B. *Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach**. 8ª ed. Sydney: Saunders Ltd.; 2015.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.